

CYCLE DE VIE DU MEDICAMENT - CHAPITRE 6

REMBOURSEMENT DES PRODUITS DE SANTE

Objectifs :

- Quelles sont les parties décisionnaires du remboursement d'un produit de santé
 - Commission de transparence (médicaments)
 - CNéDiMTS (DM)
- Critères et procédure de fixation du taux de remboursement d'un PS remboursable

I) REMBOURSEMENT

1. MEDICAMENTS

1.1. CLASSIFICATION

Selon la SANTE PUBLIQUE	• Produits listés (PMO : prescription médicale obligatoire) • Produits non listés (PMF : prescription médicale facultative)
Selon MILIEU D'UTILISATION	• Milieu hospitalier • Ambulatoire
Selon PROTECTION SOCIALE	• Pris en charge par un organisme de protection sociale (prix régulé) • Non pris en charge (prix libre)

1.2. MODALITES DE REMBOURSEMENT : COMMISSION DE TRANSPARENCE

Une fois l'AMM obtenue avec les indications définitives, le labo fournit 2 dossiers de demandes :

- **Dossier technique** : commission de transparence (HAS)
- **Dossier économique** : comité économique des PS (CEPS)

HAS
• Evaluation de l'utilité des biens et services d'un point de vue médical et économique en vue de leur remboursement • Régulation du système de santé par la qualité et l'efficacité (résultat obtenu/moyens investis) • Recommandations sur les stratégies de prise en charge
COMMISSION DE TRANSPARENCE
• Rattachée à l'H.A.S. (janvier 2005) : une des 8 commissions spécialisées) • Evaluation scientifique des médicaments ayant obtenu leur AMM (lorsque le laboratoire qui les commercialise souhaite obtenir leur inscription sur la liste des médicaments remboursables) • Examen des demandes d'inscription, d'extension d'indications thérapeutiques ou de réinscription • sur la liste des spécialités remboursables • sur la liste des médicaments agréés aux collectivités C'est obligatoirement une demande du labo pour l'inscription sur l'une ou les deux listes • Réévaluation des classes thérapeutiques : modification SMR et déremboursements éventuels • Avis sur des documents relatifs au bon usage du médicament (fiches de transparence, recommandations, référentiels de bon usage) • Rédige la Fiche d'Information Thérapeutique (FIT) des médicaments d'exception

II) CONDITIONS DE PRIS EN CHARGE

1. MEDICAMENTS – LES CRITERES

MEDICAMENTS SMA/SMR

MODALITES	- Les médicaments sont inscrits sur la liste (des médicaments remboursables) au vu de l'appréciation du service médical attendu/rendu (SMA/SMR) qu'ils apportent indication par indication - La validité : 5 ans au plus mais renouvelable
CRITERES	L'appréciation prend en compte 5 critères liés à la valeur intrinsèque du produit efficacité et effets indésirables du médicament place dans la stratégie thérapeutique au regard des autres thérapies disponibles gravité de l'affection à laquelle il est destiné - caractère préventif, curatif ou symptomatique du traitement médicamenteux - intérêt pour la santé publique - Evaluation de la population cible - Selon les indications, un avis peut comporter plusieurs SMR différents
CONDITIONS	- Le niveau de SMR/SMA conditionne le taux de prise en charge - Si SMR insuffisant au regard des médicaments ou thérapies dispo : pas d'inscription sur la liste (pas de prise en charge) Génériques des spécialités de référence : non examinés par la Commission
NIVEAUX	3 niveaux suffisants + 1 insuffisant SMR important : 65% SMR modéré : 30% SMR faible : 15%
MEDICAMENTS D'EXCEPTION	
- L'inscription sur la liste peut être assortie (médicaments coûteux/indications précises) : clause prévoyant remboursement ou prise en charge qu'après information du contrôle médical - Dans ce cas : fiche d'information thérapeutique (FIT) établie par la commission de Transparence FIT : destinée aux professionnels de santé, rassemble les indications et les modalités d'utilisation du médicament, règles de prescription et de délivrance - Mentionne, le cas échéant, les restrictions apportées par l'AMM à la prescription et à la délivrance du médicament dit d'exception (médicaments soumis à prescription restreinte)	
AGREMENT AUX COLLECTIVITES	
- Permet l'achat et l'utilisation à l'hôpital et diverses collectivités - Etablie par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, après avis de la HAS - Demandé par l'industriel, soit isolément, soit simultanément à la demande d'inscription sur la liste des spécialités remboursables	

2. DM

2.1. COMMISSION NATIONALE D'EVALUATION DES DISPOSITIFS MEDICAUX ET DES TECHNOLOGIES DE SANTE

Procédure d'inscription une fois le marquage CE obtenu :

- Dossier destiné à la HAS : **dossier technique d'évaluation scientifique**
- **CNEDDiMTS** : examen du dossier
- **Avis de la HAS** sur le service attendu ou rendu (**SA/SR**) ou amélioration du SA/SR, population cible

CNEDiMTS
- Rattachée à la HAS - Evaluation : bon usage des DM et des technologies de santé - Formulation de recommandations sur des bases scientifiques

- Avis en vue du **remboursement des DM** à usage individuel ou d'autres produits à visée diagnostique, thérapeutique ou de compensation du handicap

2.2. CONDITIONS DE PRISE EN CHARGE – LES CRITERES

DISPOSITIFS MEDICAUX – SA/SR	
•	SA/SR et SMA/SMR : mêmes critères
•	Evaluation population cible (susceptible de bénéficier du dispositif dans l'indication revendiquée)
•	Inscription sur la liste des produits ou prestations (LPP) • sous nom générique : démontrer l'équivalence du DM concerné avec un DM déjà inscrit = inscription est alors automatique • sous nom de marque : faire un dossier complet

ARGUMENTATION POUR LE SR	
Description et évaluation du besoin médical	• <u>Gravité</u> de la pathologie/handicap • <u>Données épidémiologiques</u> : prévalence/incidence • <u>Population</u> de patients concernés
Stratégie thérapeutique actuelle	• <u>Moyens thérapeutiques existants</u> • <u>Stratégie de référence</u> • <u>Place du DM</u> évalué
Effet clinique du DM évalué	• <u>Effet thérapeutique</u> /diagnostic /compensation du handicap / risques • Fondé sur des études cliniques publiées ou rapports d'études
Intérêt de santé publique	• <u>Impact prévisible</u> sur le système de soins / politique et programmes de santé publique • <u>Impact potentiel</u> sur la santé de la population